SDD 75 Sujet n°1

Spécialité : Traumatologie

Date : 29/09/23
Auteur : LOPES Adrien
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble, ECN 2023), Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Entretien/interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez : un brûlé, un polytraumatisé, un traumatisé thoracique, un traumatisé abdominal, un traumatisé des membres et/ou du … Lésions péri-articulaires et ligamentaires du genou, de la cheville et de l'épaule
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 75
Matériel nécessaire à la station	1 bureau 2 chaises 1 table d'examen clinique
Contexte de la station	Instabilité du genou

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en médecine générale en stage aux urgences, vous recevez Adrien P. un patient de 25 ans sans antécédent particulier pour une impotence fonctionnelle du genou droit.
Il a senti un craquement, et a senti une rotation externe de son genou droit avec douleur brutale. Il a maintenant une douleur évaluée à 5/10, calmée par du paracétamol.
Il s'est blessé lors d'un match de foot la veille et boite depuis.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Enoncer les éléments à rechercher à l'examen clinique
- Emettre une hypothèse diagnostique

Vous ne devez pas :

- Réaliser de prescription
- Énoncer de prise en charge

Les résultats de votre examen physique seront transmis à votre demande lors que vous considérez avoir finir celui-ci

Il s'agit d'une station sans patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Examen clinique : point accordé si énonce le nom du test ou le décrit, sans nécessité d'énoncer tous les éléments de l'item		
1.	Regarde le patient **debout**	1 pt
2.	Énonce la nécessité **d'examiner la marche** du patient	1 pt
3.	Réaliser un **examen cutané** du patient : recherche une rougeur ou recherche une chaleur émanant de l'articulation (en posant sa main sur l'articulation) ou une plaie	1 pt
4.	**Rechercher flessum**/recurvatum *(patient couché sur le dos, le/la candidat.e soulève le pied du patient)*	1 pt
5.	Recherche une **réduction du flessum**	1 pt
6.	**Examen des points d'angles postérieurs** (PAPE et PAPI) + LCL et LCM : Patient couché sur le dos, genou en extension à **0°**, puis mobilise le genou latéralement puis médialement	1 pt
7.	**Examen des LCL et LCM isolé** : patient couché sur le dos, genou à **30°**, puis mobilise le genou latéralement puis médialement	1 pt
8.	Rechercher un **oedème du genou** avec la méthode du glaçon *(patient en position couché, entoure de ses 2 mains le genou et appuie sur la rotule)*	1 pt
9.	Examine le ménisque : **Palpation de l'interligne osseuse** (Genou à 80°, puis recherche espace entre tibia et rotule, puis palpe les doigt horizontaux à l'interligne)	1 pt

10.	**Grinding test** : Patient couché sur le ventre, genou plié à 90°. Puis appui dans l'axe du tibia sur le genou et ensuite : ○ Met en rotation externe le genou (teste le ménisque interne) ○ Met en rotation interne le genou (teste le ménisque externe)	1 pt
11.	Réalise un **signe de mc murray** : Patient couché sur le dos, genou fléchi. Puis teste de 2 façons : ○ Rotation latérale du tibia et mise en extension complète du genou ○ Rotation médiale du tibia et mise en extension complète du genou	1 pt
12.	Énonce la **réalisation des tests en bilatéral**	1 pt
13.	Recherche d'un **tiroir antérieur** (signe de Lachman) : Genou mis entre 30 et 60°, puis l'autre main tire le tibia en avant en a-coup.	1 pt
14.	Recherche **tiroir postérieur** : Genou mis entre 70 - 80°, puis l'autre main pousse le tibia en arrière	1 pt
	Hypothèse diagnostique	
15.	Évoquer une lésion méniscale externe du genou droit *(tous les mots nécessaires pour avoir le point)*	1 pt
	Communications et attitudes (ICI)	

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

TOTAL (max 20 items)	**…/16 points**

PAPE : Point d'Angle Poplité Externe
PAPI : Point d'Angle Poplité Interne
LCA : Ligament Croisé Antérieur
LCP : Ligament Croisé Postérieur
LCL : Ligament Collatéral Latéral
LCM : Ligament Collatéral Médial
EVA : Échelle Visuelle Analogique

Éléments de rétroaction :

Un examen du genou se doit d'être bilatéral pour les ligaments et l'oedème du genou

Résultats de l'examen physique à transmettre à l'étudiant à la fin de son examen :

Son genou est bloqué avec un flessum mécanique (le genou reste fléchi même quand veut l'étendre). Appui fuyant lors de la marche La réduction du flessum laisse un flessum résiduel malgré la réduction Douleur augmentée à 7/10 à la palpation de la partie externe du genou Grinding test : douleur à 7/10 Signe de Mac Murray externe : douleur à 7/10 Douleur résiduelle malgré un doliprane Pas de douleur ou de modification lors des manoeuvres de tiroir Pas de modification de l'état cutanée ou sensitif